l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Caisse nationale

Fiche technique de l'indicateur
Catégorie : **Vaccination**
Trigramme : **COV**
Version : **1.0**

I. Description

Parmi les personnes de 65 ans et plus ou celles de 6 mois et plus et à risque de covid sévère, l'indicateur est validé pour celles ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le covid lors de la campagne de vaccination en cours. Les campagnes de l'hémisphère Nord et de l'hémisphère Sud sont concaténées pour couvrir une période de 1 an, allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les personnes de 65 ans et plus ou celles de 6 mois et plus et à risque de covid sévère […]* » :

- Age ≥ 65 ans
  OU
- Age ≥ 6 mois
  ET
  - ALD active, avec un code CIM10 associé correspondant à l'un des items suivants :
    - ALD 1 – Accident vasculaire cérébral invalidant
    - ALD 2 – Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques
    - ALD 3 – Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques
    - ALD 5 – Insuffisance cardiaque, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires congénitales graves
    - ALD 6 – Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
    - ALD 7 – Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH
    - ALD 8 – Diabète de type 1 et diabète de type 2
    - ALD 9 – Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave
    - ALD 10 – Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères
    - ALD 12 – Hypertension artérielle sévère
    - ALD 13 – Maladie coronaire
    - ALD 14 – Insuffisance respiratoire chronique grave
    - ALD 15 – Maladie d'Alzheimer et autres démences
    - ALD 16 – Maladie de Parkinson
    - ALD 18 – Mucoviscidose
    - ALD 19 – Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique
    - ALD 20 – Paraplégie
    - ALD 21 – Panartérite noueuse, lupus, sclérodermie généralisée
    - ALD 22 – Polyarthrite rhumatoïde
    - ALD 23 – Affections psychiatriques de longue durée
    - ALD 24 – Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
    - ALD 25 – Sclérose en plaques
    - ALD 27 – Spondylarthrite ankylosante grave
    - ALD 28 – Suites de transplantation d'organe
    - ALD 30 – Tumeur maligne

OU

- Au moins 4 délivrances de médicaments bronchodilatateurs (classe ATC = « **R03**** ») dans les 12 derniers mois
  OU
- Au moins 1 délivrance de médicaments immunosuppresseurs (classe ATC = « **L04**** ») dans les 12 derniers mois

2. Critères d'exclusion

Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le covid lors de la campagne de vaccination en cours.* » :

- Administration d'une dose de vaccin contre le covid (codes de facturation = « **INJ** », « **VAC** », ou « **SKA** ») depuis le début de la campagne en cours (1er avril dernier)
  OU
- Délivrance d'une dose de vaccin contre le covid (classes ATC = « **J07BN** » ou « **J07BB55** ») depuis le début de la campagne en cours (1er avril dernier)

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patient « médecin traitant » de 65 ans et plus, ou de 6 mois et plus et à risque de covid sévère, au 31/12 de l'année N, le médecin est rémunéré si le patient a reçu au moins une dose de vaccin contre le covid au titre de la campagne de vaccination en cours au 31/12 de l'année N, c'est-à-dire entre le 01/04 et le 31/12 de l'année N.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre la vaccination contre le covid parmi ses patients éligibles à cette vaccination.

Conformément aux recommandations en vigueur, la vaccination contre le covid repose sur une dose de rappel à réaliser à chaque campagne de vaccination, à l'automne (septembre/octobre pour l'hémisphère Nord et Mayotte, avril/mai pour l'hémisphère Sud, et notamment la Réunion). Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a reçu une dose de vaccin contre le covid au titre de la campagne de vaccination en cours. Les campagnes de l'hémisphère Nord et de l'hémisphère Sud étant décalées dans l'année, elles sont concaténées de façon à couvrir une période continue de 1 an, allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante : le statut de l'indicateur est ainsi réinitialisé chaque 1er avril pour l'ensemble de la population cible, quel que soit le territoire de résidence.

Le ciblage de la population éligible s'appuie sur le calendrier vaccinal élaboré par le ministère chargé de la santé. Il s'agit de toutes les personnes de 65 ans et plus, ainsi que des personnes de 6 mois et plus à risque de covid sévère. Cette notion de « risque de covid sévère » repose

sur la présence d'une affection de longue durée exposant à un risque accru de forme grave, ou sur un recours régulier à des médicaments bronchodilatateurs (marqueur d'un asthme ou d'une bronchopneumopathie chronique obstructive), ou sur la délivrance de médicaments immunosuppresseurs. Le périmètre des ALD retenues est identique à celui de l'indicateur relatif à la vaccination contre la grippe, à l'exception des affections psychiatriques de longue durée (ALD 23), retenues uniquement pour le covid.

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Calendrier des vaccinations : https://sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/vaccination/calendrier-vaccinal

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Facteur de risque de covid sévère présent mais :
  - Sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée ;
    ET
    - Sans traitement médicamenteux ;
      OU

- Médicaments délivrés par la pharmacie interne dans le cadre d'un séjour en établissement ;

b. Critères d'exclusion

- Pas de critère d'exclusion pour cet indicateur.

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Dose de vaccin contre le covid administrée hors du circuit de facturation à l'assurance maladie (centre de vaccination, campagne de vaccination collective, etc.) ;
- Dose de vaccin contre le covid administrée dans le cadre d'un séjour en établissement de santé ou au sein d'un établissement médico-social (EHPAD notamment), sans codage spécifique de l'acte.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : 12 mois pour les médicaments uniquement
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : pas de critère d'exclusion
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 1er avril dernier
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : décembre 2020

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- × PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie